

# Rekam Medis sebagai Dasar Pengajuan Klaim

17 Juni 2026

**Pusat Pembiayaan Kesehatan**



# Dokumentasi Pada Rekam Medis



## Kepentingan Rekam Medis

1. Kesiambungan pelayanan pasien
2. Keselamatan pasien
3. Aspek hukum
4. Akreditasi
5. Klaim
6. Audit mutu layanan



Di era pembiayaan berbasis INA-CBG/iDRG, kualitas rekam medis menentukan:

1. Validitas diagnosis/tindakan
2. Severity Level
3. Keberhasilan klaim.



## Rekam Medis merupakan:

1. Dokumen hukum
2. Rahasia medis
3. Alat bukti pelayanan.



Dokumentasi rekam medis yang **lengkap**, **akurat**, dan **tepat waktu** adalah **kunci pelayanan yang berkualitas** dan **keberhasilan klaim**.

## Hal yang Sering Menyebabkan Masalah Klaim

01



Diagnosis **tidak spesifik**.

02



CPPT **tidak sinkron** dan tidak sesuai dengan durasi penggunaan ventilator.

03



Resume medis **tidak lengkap**.

04



Tindakan **tidak terdokumentasi dengan jelas** dan terperinci.

05



**Tidak ada justifikasi** yang dapat menyebabkan kenaikan severity (Komorbid/Komplikasi).

06



**Copy-paste berlebihan** pada catatan harian.



# Prinsip Rekam Medis yang Baik

## LENGKAP

Semua informasi penting pasien **tercatat, mencakup**: anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, terapi dan tindakan yang diberikan, edukasi kepada pasien/keluarga, perkembangan pasien.

## AKURAT

Isi rekam medis harus sesuai **kondisi klinis**, Tidak dilebihkan atau tidak dikurangi, serta dapat apa dipertanggungjawabkan.

## JELAS & SPESIFIK

Hindari **diagnosis terlalu umum** seperti "infeksi", "sesak", "CKD". Gunakan istilah medis baku dan spesifik seperti: "Sepsis ec pneumonia", "Chronic Kidney Disease stage V on HD".

## TEPAT WAKTU

Pencatatan dilakukan **segera setelah pelayanan diberikan** untuk menjaga **validitas dan kronologis informasi**.

## KONSISTEN

Isi rekam medis (CPPT, resume medis, instruksi dokter, hasil tindakan dll) **harus konsisten antar bagian dan antar tenaga kesehatan dan harus sinkron**

## MUDAH DIBACA

Tulisan harus **Jelas**, Tidak ambigu, Menggunakan istilah medis baku.



Rekam medis **yang lengkap, akurat, jelas, tepat waktu, konsisten** dan **mudah diaca** merupakan dasar keberhasilan klaim JKN dan keselamatan pasien.



# Komponen Penting Rekam Medis

## A. Identitas Pasien

- Nama Lengkap
- Nomor RM
- Tanggal lahir
- Jenis kelamin

## B. Anamnesis harus memuat:

- Keluhan utama
- Riwayat penyakit sekarang
- Riwayat penyakit dahulu
- Faktor risiko.

## C. Pemeriksaan Fisik

Ditulis objektif dan lengkap sesuai kasus.

## D. Diagnosis

Gunakan diagnosis spesifik.  
Contoh: jangan hanya "stroke"  
tetapi: Ischemic Stroke non  
hemorrhagic onset <24 jam.

## E. Pemeriksaan Penunjang

Cantumkan:

- hasil laboratorium
- Radiologi : Thorax, CT Scan/MRI dll
- EKG/ Echo
- Gram/kultur dll

## F. Terapi dan Tindakan

Tuliskan:

- Nama/jenis Obat
- Dosis pemakaian
- Tindakan/prosedur/Operatif
- Informed consent secara jelas akan dilakukan apa dengan persetujuan

## G. Catatan Perkembangan (CPPT)

Harus menggambarkan:

- Kondisi pasien
- Respons terapi
- Rencana tindak lanjut, Biasanya menggunakan format: SOAP

# Dokumentasi yang Penting dalam Klaim JKN/iDRG



## Strategi Membuat Dokumentasi Lebih Baik



### **DIAGNOSIS SPESIFIK**

Sesuai kaidah pengodean dan kondisi klinis pasien.



### **EVIDENCE KINIS HARUS TERTULIS**

Dukung setiap diagnosis dan tindakan dengan data objektif.



### **HINDARI SINGKATAN AMBIGU**

Gunakan istilah medis baku dan mudah dipahami.



# Contoh Membuat Dokumentasi Rekam Medis (1/2)



## A. IDENTITAS PASIEN

Nama: Tn. A  
Umur: 62 tahun  
Jenis Kelamin: Laki-laki  
Tanggal Masuk: 20 Mei 2026  
Nomor RM: 00XXXXXX



## B. ANAMNESIS IGD

### Keluhan Utama :

Nyeri dada sejak 4 jam lalu.

### Riwayat Penyakit Sekarang

Pasien datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada kiri sejak  $\pm 4$  jam sebelum masuk rumah sakit. Nyeri terasa seperti tertindih beban berat, menjalar ke lengan kiri dan rahang, disertai sesak napas dan keringat dingin.

Nyeri tidak membaik dengan istirahat. Riwayat hipertensi (+), diabetes melitus tipe 2 (+), merokok berat sejak usia muda. Pasien minum obat untuk hipertensi dan DM secara rutin tetapi sudah 6 bulan terakhir tidak pernah kontrol ulang ke dokter.

### Riwayat Penyakit Dahulu

- Hipertensi
- Diabetes Tipe 2 NIDDM
- Dislipidemia



## C. PEMERIKSAAN FISIK

Keadaan umum: tampak sakit berat

Kesadaran : compos mentis

TD : 90/60 mmHg

Nadi : 112 x/menit

RR : 28 x/menit

SpO2 : 90% RA

Suhu : 36,8°C



bunyi jantung reguler  
gallop S3 (+)



ronki basal bilateral (+)



CRT memanjang  
edema tungkai (-)



## E. DIAGNOSIS AWAL

### Diagnosis Utama

ST-Elevation Myocardial  
Infarction anterior luas Killip III.



## D. PEMERIKSAAN PENUNJANG

### 1. Hasil EKG :

Terdapat ST-Elevation Myocardial  
Infarction anterior luas.

### 2. Troponin

(ditulis nilainya ) -> Kesan :  
Meningkat signifikan.

### 3. Echocardiography

EF 30% dan Hipokinesia anterior  
luas

### 4. Coronary Angiography

- Left Main stenosis 70%
- LAD stenosis 90%
- RCA stenosis 80%

### Diagnosa Sekunder :

- Hypertension
- Diabetes Tipe 2 NIDDM
- Dislipidemia



# Contoh Membuat Dokumentasi Rekam Medis



## F. RENCANA TATALAKSANA

- Rawat intensif ICCU
- Oksigen NRM 10 lpm
- DAPT:
  - Aspirin
  - Clopidogrel
- Antikoagulan
- Diuretik IV
- Vasopressor sesuai kondisi hemodinamik
- Konsul Bedah Toraks Kardiovaskular



## G. SOAP HARIAN



## H. INFORMED CONSENT

Telah dijelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai:

- kondisi penyakit
- indikasi operasi CABG
- risiko perdarahan, stroke, gagal jantung, kematian intraoperatif dan pascaoperatif.

**Keluarga memahami dan menyetujui tindakan operasi.**



## I. LAPORAN OPERASI

(Dibuat terperinci sejak pasien masuk ke kamar Operasi, dilakukan Tindakan anestesi dll sampai kepada apa yang ditemukan/ dilakukan pada Tindakan operasi)

**Tindakan Operasi :** Coronary Artery Bypass Grafting 3 graft.

### Temuan Operasi :

- Terdapat Severe triple vessel disease
- LV dysfunction berat

### Jalannya Operasi

Operasi dilakukan dengan general anesthesia menggunakan CPB. Dilakukan:

- LIMA to LAD
- SVG to OM
- SVG to RCA

Operasi berlangsung  $\pm 5$  jam, Hemodinamik relatif stabil intraoperative, operasi selesai pukul....., selanjutnya pasien dipindahkan ke perawatan ICU untuk tata laksana lebih lanjut.



## J. PERAWATAN ICU PASCA OPERASI

### Hari Pertama ICU :

- Pasien dengan ventilator mekanik, dipasang sejak kapan? (pukul berapa?), CPPT Harian ditulis dengan jelas
- Hemodinamik: TD 88/55 mmHg dengan norepinefrin support (berapa ??), Produksi urin menurun (tuliskan jumlah cc urin).
- **Diagnosis:** low cardiac output syndrome post CABG.



## K. PERBURUKAN KONDISI

**Hari ke-3 Pasca Operasi,** Pasien mengalami:

- hipotensi progresif (berapa TD?)
- penurunan kesadaran sejak kapan...?
- asidosis metabolic (nilai hasil lab harus ada) dan tata laksana koreksi
- Oliguria (berapa cc?)

**EKG menunjukkan VT kemudian VF (pukul berapa)... dilakukan apa?? RESUSITASI? (waktunya?, berapa lama?) misalnya :**



**ROSC sempat tercapai  $\pm 10$  menit,** Namun pasien kembali mengalami **pulseless electrical activity (pukul??)** hingga akhirnya dinyatakan meninggal (pukul???)

## KESIMPULAN

1. **Dokumentasi** rekam medis yang baik harus:

- lengkap, akurat, spesifik, konsisten, dan dibuat tepat waktu.

2. **Diagnosis spesifik** : Tidak hanya “sakit jantung”.

3. **Evidence lengkap** : terdapat hasil EKG / echo / angiografi / penunjang lainnya

4. **Justifikasi tindakan lengkap** : Mengapa perlu CABG, perawatan ICU dengan Ventilator.

5. **Kronologis jelas** : Dari pasien masuk RS → operasi → komplikasi → meninggal.



